

OK

INDICADO POR: Dou. Mario Jorge
☒ ACOMPANHAMENTO () CONSULTA
NS

IVANIA MARIA PEREIRA

IDADE: 70	PESO: 70	ALTURA: 1,59	PROFISSÃO: Aposentada (professora)
SINTOMAS: <u>Canção durante o dia, Demos prejudicados,</u>			
QUEIXAS: <u>Sonolência diurna / Pesadelos / Demora p/ acordar.</u>			
MEDICAMENTOS: <u>Rivarte / Lisdina / Pous / Latinal / Rensat / Betrat</u> <u>Ocal / Sinbata</u>			
MÉDICO: <u>Dr. Mario Jorge (neuro)</u>			
MARCAPASSO: () S ☒ N / COMPANHEIRO USA MARCAPASSO: () S ☒ N			
EXERCÍCIO FÍSICO: <u>Pilates / musculação 2x semana / hidroginástica</u>			
HORÁRIO DAS REFEIÇÕES: CAFÉ: 5 ALMOÇO: 5 LANCHE: JANTAR: 23h			
HORA QUE DORME: <u>0h-1h</u> HORA QUE ACORDA: <u>6h</u>			
COCHILHO () S ☒ N DORME ACOMPANHADO: () S ☒ N () EVENTUALMENTE			
TEM FILHOS: (X) S () N / DORMEM NO QUARTO: () S ☒ N PET NO QUARTO: () S ☒ N			
BEBIDA ALCOÓLICA: () S () X NA SEMANA ☒ N			
FUMO: () S () MAÇO/DIA (X) NÃO - PAROU A QUANTO TEMPO:			
TIPO DE RESPIRAÇÃO: <u>nasal</u> BANHEIRO/NOITE: <u>2x</u>			
CIRCUNFERÊNCIA ABDOMINAL: CIRCUNFERÊNCIA PESCOÇO:			
OVERLAP: <u>none</u> MALLAMPATI: <u>III</u> IAH: <u>52/3elh</u> SPO2: <u>72%</u>			
PATOLOGIAS ASSOCIADAS: <u>Dinite / HAS / dor no de splo</u>			
CIRURGIAS: (N) NASAL (N) AMIGDALECTOMIA			
HIPERVENTILAÇÃO DA OBESIDADE:			
COMORBIDADE: (N) RESPIRATÓRIA (N) ENDÓCRINA (S) CARDÍACA			
(S) ORTOPÉDICA (N) NEUROLÓGICA () OUTROS:			
POLISSONOGRAMA COM CPAP: () S () N SPO2 C/ CPAP: PRESSÃO NO EXAME:			
27/02/25 Avaliação Localização Max N30: (S)			
Natacha			
14/03/25 P=5.9cmH ₂ O / fixo P=6cmH ₂ O			
IAH=2.2elh Relata aerofagia			
m de uso: 6h2' Orienta elevação cabeça			
fuga: 13.8l m (percentil) da cama			
Natacha			
24/03 P=6cmH ₂ O Relata estar acordando			
25 IAH=1.8elh despostos.			
m. de uso: 6h16'			
fuga: 0.3 lpu. Jua			

01/03 P = 6cmH₂O
25 IAH = 1,9 elev
M. de uso: 7hrs 05'
Bem adaptada, relata estar + segura. sua

14/04 P = 6cmH₂O
25 IAH = 1,2
M. de uso: 7hrs
fuga = 16 lpm
relata que o nariz está ficando + escape de ar, melhorou os perasdelos, + muito as idas ao banheiro.

26/04 P = 6cmH₂O
25 IAH = 1,7 elev
M. de uso: 6h48'
fuga = 23,4 lpm.

sua cláudia

35/05 P = 6cmH₂O
25 IAH = 1,8 elev
Fuga = 3,0 lpm.
M. de uso = 7hrs.

~~sua~~ sua cláudia

09/06 P = 6cmH₂O
25 IAH = 5,2 elev
M. de uso: 6h23'
fuga = 3,9

~~sua~~ sua

30/06 P = 6cmH₂O
25 IAH = 4,0 elev
M. de uso: 6h54'
fuga = 4,6 lpm.

esta + seg^{ta} nasal à (E).
Tem desvio septo à (E).
E a HAS está descontrolada (+ a medicação). sua

Nome: IVANIA MARIA PEREIRA

Data de Nascimento: 28-6-1954

IMC: 24,69

Sexo: Feminino

Data do exame: 05-06-2024

Peso: 64 kg

Altura: 1,61 m

Médico: DR. LAURO BENEDITO HANNA

Medicamentos:

Histórico:

Laudo de Polissonografia

Exame realizado na noite de 05-06-2024, sendo feita avaliação simultânea de eletroencefalograma, eletrooculograma, eletromiograma (região submentoniana e músculo tibial anterior), posição corporal, ronco, fluxo aéreo nasal e oral, esforço respiratório torácico e abdominal, saturação arterial de oxigênio (SpO2) e eletrocardiograma. Os resultados encontram-se em anexo.

O tempo total de registro foi de 484,5 min. As latências de estágio N1 e sono de REM foram, respectivamente, 32,0 e 223,5 minutos. O tempo total de sono foi de 314,5 min, eficiência de 64,9% (normal > 85%) e as porcentagens das fases de sono em relação ao tempo total de sono foram: estágio N1: 1,9%; estágio N2: 73,8%; estágio N3: 9,9%; sono REM: 14,5%. O índice de despertares foi de 33,2/hora (normal < 10/h).

O índice de apneia/hipopneia total foi de 52,3/hora, sendo 26 obstrutivas, 0 mistas e 0 centrais e 156 hipopnéias. A SpO2 média foi de 91% e a mínima de 72%, permanecendo 13,8% do tempo de registro com a saturação abaixo de 90%. A frequência cardíaca no estágio REM oscilou entre 59 - 72 bpm e NREM de 58 - 74 bpm.

CONCLUSÃO: Os dados do registro polissonográfico, associados aos do Questionário de Sono e escala de Epworth (13), favorecem as seguintes hipóteses diagnósticas:

1. Polissonografia demonstrando eficiência do sono reduzida;
2. porcentagem do sono REM e do estágio N3 do sono NREM diminuída e porcentagem do estágio N2 do sono NREM aumentada;
3. índice de apnéia + hipopnéia (IAH) de 52,3/hora;
4. houve dessaturação da oxihemoglobina (min. SaO2=72%);
5. latências para o sono prolongadas;
6. aumento do número de despertares breves;
7. presença de atividade em EMG de queixo;
8. presença de movimentos periódicos de membros inferiores (10,3/hora);
9. registro de ronco durante o sono.

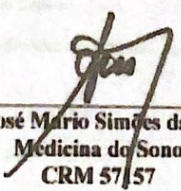
**Exame evidenciando apneia obstrutiva do sono e dessaturação de graus acentuados.
Presença de bruxismo ou apertamento.**

IAH: 05-15 /hora leve.

IAH: 15-30 /hora moderada.

IAH: > 30 /hora acentuada.

Nota: O diagnóstico depende da correlação conjunta com outros fatores.


Dr. José Mario Simões da Costa
Medicina do Sono
CRM 57/57